

Incontinencia urinaria en la mujer: evaluación y manejo práctico en atención primaria

Pablo Oteo Manjavacas^{a,*}, Francisco Donis Canet^a, Cayo Augusto Estigarribia Benítez^b y José Costell Jaime^c

^aServicio de Urología. Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés. Madrid. España.

^bServicio de Urología. Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida. España.

^cServicio de Urgencias Generales. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. España.

*Correo electrónico: pablooteo@hotmail.com

Puntos para una lectura rápida

- La distinción entre incontinencia urinaria (IU) de esfuerzo secundaria a un defecto en el sistema de cierre del esfínter uretral y la incontinencia secundaria a las contracciones involuntarias del detrusor es fundamental a la hora de ofrecer un tratamiento adecuado a la paciente.
- Para ello, la exploración física con maniobras especializadas como el test de Bonney o el test del hisopo se asientan como imprescindibles junto a una adecuada anamnesis.
- Los cuestionarios de calidad de vida se consolidan como herramientas fundamentales en el manejo de la IU. Algunos de uso estandarizado, como el *International Consultation on Incontinence Questionnaire* (ICIQ), de utilidad en primera consulta y durante el seguimiento.
- La IU de esfuerzo se beneficia principalmente de los cambios en los hábitos de vida, los ejercicios de suelo pélvico y de forma marginal del tratamiento farmacológico.
- Los fármacos anticolinérgicos y los agonistas beta-3 se mantienen al frente en el tratamiento de la IU de urgencia, aunque determinados estudios nos permiten orientar cada molécula a una paciente determinada.
- Resulta imprescindible identificar aquellos síntomas que nos orienten hacia una IU maligna o que revelan un trastorno genitourinario grave y, por lo tanto, debe ser valorado por un especialista.

Palabras clave: Incontinencia urinaria femenina • Primera evaluación • Calidad de vida • Tratamiento conservador • Tratamiento farmacológico.

Introducción

De acuerdo con la definición de la Sociedad Internacional de Continencia, la incontinencia urinaria (IU) es toda pérdida involuntaria de orina, independientemente de la causa subyacente que la produzca. Se trata de una patología muy prevalente en mujeres de edad avanzada y fuertemente limitante por la pérdida de autonomía y autoestima que conlleva. La IU es un motivo de consulta cada vez más habitual debido al envejecimiento progresivo de una población que no quiere renunciar a su calidad de vida. Su evaluación en atención primaria deberá determinar el tipo y la gravedad de la IU con el objetivo de iniciar una terapia efectiva e identificar

aquellas pacientes que deban ser derivadas al especialista desde el inicio¹.

Clasificación

Durante el diagnóstico es muy importante clasificar correctamente cada tipo de IU, ya que esto va a determinar nuestra actuación terapéutica y el éxito de esta.

Podemos clasificar la IU como:

- IU de esfuerzo (IUE): es la pérdida involuntaria de orina, asociada a un esfuerzo físico que conlleve un aumento

de la presión en el abdomen, como por ejemplo un estornudo, la tos, la risa o simplemente caminar.

- IU de urgencia (IUU): es la pérdida involuntaria de orina precedida de urgencia y un deseo imperioso de realizar micción que no puede ser controlado.

- IU mixta (IUM): se refiere a aquellas pacientes que combinan las dos formas de IU descritas anteriormente. Hasta un 40% de las mujeres con IU presentan una incontinencia mixta.

Otras formas de IU:

- IU continua: es el fallo completo de la continencia con pérdidas continuadas de orina.

- Enuresis nocturna: es la pérdida involuntaria de orina durante la noche, pudiendo el paciente presentar o no síntomas durante el día.

- Incontinencia por rebosamiento: donde se producen pérdidas de orina en el contexto de una retención aguda o crónica. Puede ser causado por una patología obstructiva o una vejiga neurógena y viene precedido por dificultad de inicio de la micción.

Aunque no se trate de una verdadera IU, hay que destacar el concepto de incontinencia funcional. Se trata de aquellas pérdidas de orina que presenta el paciente al no ser capaz de llegar al baño a tiempo por problemas de movilidad reducida, una circunstancia frecuente en el paciente añoso.

Fisiopatología de la incontinencia urinaria

La fisiopatología de la IU difiere según el tipo de incontinencia. La IUE se produce cuando la presión intravesical supera la presión de apertura uretral, como consecuencia de un fallo en los mecanismos de resistencia uretral, por dos causas no excluyentes: la hipermovilidad uretral, secundaria a la debilidad de las estructuras que conforman el suelo pélvico y que sostienen la uretra, y la deficiencia intrínseca del esfínter, producida por un defecto en el sistema de cierre del esfínter uretral y que determina la insuficiente coaptación de sus paredes². En el caso de la IUU, la causa de esta urgencia es la contracción involuntaria del músculo detrusor vesical. Esta hipercontractibilidad viene mediada por la vía parasimpática, que produce la contracción del detrusor en pacientes con una hipersensibilidad de los receptores muscarínicos M2 y M3 a la acetilcolina (ACH), localizados en la musculatura de la vejiga.

Factores predisponentes

Entre los factores predisponentes a presentar IU cabe citar los siguientes:

- Edad: la IU no debe considerarse una patología intrínseca al envejecimiento, pero hay algunos factores inherentes a la edad que la favorecen. Se trata sobre todo de alteraciones fisiológicas en el tono muscular, pérdida de elasticidad de los tejidos, degeneración nerviosa e hipoestrogenismo.

- Obesidad: se trata de un factor de riesgo independiente para el desarrollo de IU. Un índice de masa corporal (IMC) alto se asocia con una mayor prevalencia de IUE y una mayor de severidad de cualquier tipo de IU.

- Paridad: el parto vaginal es el factor más importante para el desarrollo de IUE en mujeres premenopáusicas. Las lesiones musculares y la debilidad del suelo pélvico secundaria a las maniobras del parto son la causa principal de la IU en pacientes multíparas.

- Tabaco: aunque no está claramente asociado a la IU, el tabaco puede favorecer de forma multifactorial la aparición de IU. La tos causada por los trastornos respiratorios crónicos y la vasculopatía del pequeño vaso acentúan los síntomas de la IU.

- Diabetes mellitus: las neuropatías periféricas secundarias a la diabetes predisponen al desarrollo de debilidad del suelo pélvico.

Evaluación clínica de la incontinencia urinaria

El estudio inicial de una paciente que acude a nuestra consulta por IU debe basarse en la anamnesis y la exploración física:

- Una correcta *anamnesis* debe recoger la historia clínica e identificar los factores de riesgo propios de cada paciente, como el IMC o la paridad. La evaluación de los síntomas irá enfocada a identificar el tipo de IU, así como la severidad y duración de los mismos. Debemos evaluar la asociación de otros síntomas miccionales acompañantes que nos puedan orientar hacia un origen infeccioso, un proceso agudo como causa de una incontinencia transitoria. Es imprescindible descartar una infección urinaria mediante la realización de un análisis sistemático de orina y un cultivo si el anterior saliese alterado.

- La *exploración física* tiene como objetivo estudiar la anatomía genital de la paciente descartando la presencia de prolapsos genitales u otras alteraciones como la atrofia bulbar. La exploración ginecológica debe ser completa, pudiendo clasificar el tipo de prolapso en caso de que la paciente lo presente (fig. 1 y tabla 1).

Una correcta exploración abdominal nos puede ayudar a identificar masas tales como un globo vesical o grandes miomas uterinos.

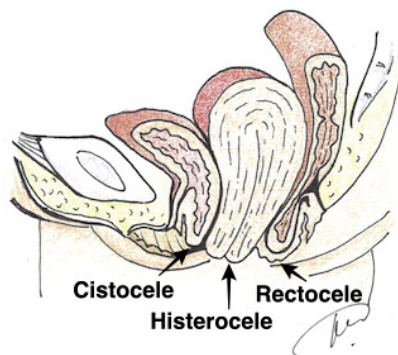


Figura 1. Recuerdo anatómico de los principales prolapsos pélvicos. Ilustración original de Pablo Oteo Manjavacas.

TABLA 1. Clasificación de los prolapsos de órganos pélvicos según el órgano afectado

Prolapso	Compartimento	Descripción
Cistocele	Anterior	Prolapso de la vejiga en la pared anterior de la vagina
Uretrocele	Anterior	Prolapso de la uretra en la pared anterior de la vagina
Histerocele	Medio	Descenso del útero a través de la vagina
Colpocèle	Medio	Descenso de la cúpula vaginal en pacientes histerectomizadas
Rectocele	Posterior	Prolapso del recto en la pared posterior de la vagina
Enterocele	Posterior	Prolapso del intestino delgado en la pared superoposterior de la vagina

A su vez, se debe realizar una exploración neurológica básica de la zona lumbosacra, evaluando el tono del esfínter anal y la sensibilidad genital³.

Una maniobra útil consiste en detectar escapes de orina al realizar maniobras de Valsalva con la vejiga llena, tanto en decúbito como en bipedestación. Esto nos haría pensar en una IUE, aunque no puede descartar una IUM.

La hipermovilidad de la uretra se puede estudiar bien mediante el test de Bonney o mediante la prueba del hisopo (Q-tip). En el test de Bonney, con la paciente acostada y la vejiga llena, le pediremos que tosa tras levantar el cuello vesical mediante un tacto vaginal, comprobando si se produce pérdida de orina o no al corregir la hipermovilidad uretral (fig. 2). La segunda prueba consiste en introducir un bastoncillo por la uretra de la paciente hasta alcanzar el cuello vesical. Oscilamos el hisopo mientras la paciente contrae la musculatura pélvica para valorar el grado de resistencia que ejerce. Si se consigue una marcada angulación con el hisopo respecto a la horizontal, podremos concluir que la paciente presenta hipermovilidad uretral (fig. 3).



Figura 2. Test de Bonney. Ilustración original de Pablo Oteo Manjavacas.

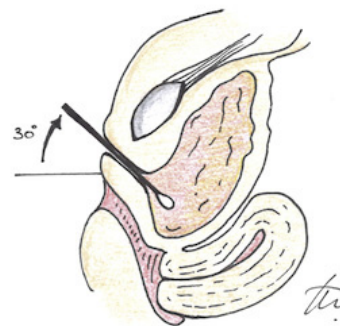


Figura 3. Prueba del hisopo o Q-tip. Ilustración original de Pablo Oteo Manjavacas.

Otras herramientas diagnósticas:

- **Diario miccional:** es una herramienta de gran utilidad para conocer los hábitos de la paciente que acude a consulta por IU. En él, la paciente anota, durante un periodo de tiempo concreto (en la actualidad suele emplearse el diario miccional de 3 días), el número de micciones, la ingesta de líquidos, el volumen vaciado, los episodios de incontinencia y la causa de estos.

- **Pad test:** Este test trata de cuantificar de manera objetiva la gravedad de la IU calculando el volumen de orina de las pérdidas acumulado en la compresa o pañal. Puede ser de 1 hora o de 24 horas de duración. Los resultados del Pad test de 1 hora muestran una gran concordancia con los test de calidad de vida, por lo que su uso es apropiado para la evaluación inicial de pacientes con IU. Por su parte, el test de 24 horas es más fácilmente reproducible, pero más difícil de estandarizar por las variaciones en la actividad física de cada paciente⁴.

A continuación, se detallan los pasos a seguir para completar este test (tabla 2):

- **Ecografía y medición de residuo posmiccional (RPM):** esta técnica de imagen nos permite descartar anomalías del aparato urinario, tales como neoplasias de vejiga, cuerpos extraños u otros hallazgos que justifiquen la aparición de la

TABLA 2. Pad test de 1 hora: pasos a seguir para su realización y grados de severidad de la incontinencia urinaria (IU)

PAD test de 1 hora	Severidad de la IU
1. La paciente debe comenzar la hora que dura el test sin orinar previamente. Pesar el pañal/compresa y ponérselo	Continente: $\leq 1,4$ g • Leve: 1,5-9,9 g • Moderada: 10-49,9 g • Severa: ≥ 50 g
2. Durante los primeros 15 minutos debe beber $\frac{1}{2}$ litro de agua y sentarse	
3. Del minuto 15 al 45 debe caminar y subir/bajar un piso de escaleras	
4. Del minuto 45 al 60 debe: • Levantarse y sentarse 10 veces seguidas • Toser fuerte 10 veces • Caminar rápido/correr durante 1 minuto • Levantar un objeto del suelo 10 veces	
5. Al final de la hora debe retirarse el pañal y pesarlo	

IU. A su vez, también podemos descartar la dilatación de tracto urinario superior en el contexto de una retención de orina crónica con incontinencia por rebosamiento.

El RPM es la cantidad de orina que queda en la vejiga tras una micción normal y puede medirse mediante sondaje vesical o, de forma no invasiva, mediante ecografía. Un RPM elevado (superior a 100-200 cm³) aumenta el riesgo de infecciones de orina y de desarrollo de fracaso renal, y puede además traducir una alteración de la fase de vaciado que pueda comprometer la realización de futuros tratamientos quirúrgicos. Es, por tanto, imprescindible descartar un RPM importante en mujeres con IU antes de plantearnos una actitud terapéutica.

• **Flujometría libre:** mide la cantidad de volumen orinado por unidad de tiempo, lo que traduce el estado de la fase de vaciado vesical. Permite identificar un flujo urinario disminuido, producido bien por una obstrucción en el tracto urinario inferior o bien por una disminución de la capacidad contráctil del músculo detrusor de la vejiga.

• **Estudio urodinámico (EU):** se trata de una herramienta diagnóstica especializada que, con una adecuada interpretación, permite clasificar el tipo de IU de forma precisa. En ella se analiza la actividad del músculo detrusor mediante electrodos localizados en la vejiga y el recto mientras se llena la vejiga de manera artificial con suero y posteriormente se procede a la micción. Consta de tres fases:

– **Flujometría libre:** realizada por la paciente antes de iniciar el estudio, es decir, antes de colocar los electrodos. Es más fisiológica.

– **Cistomanometría:** permite determinar los cambios de presión que experimenta la vejiga con el incremento progre-

sivo de volumen intravesical mientras lo representa en un registro gráfico. Así, podremos ver cómo varía la presión intravesical con el aumento de volumen (acomodación), en qué punto se producen sensaciones como el primer deseo miccional o un deseo fuerte, o podremos apreciar si el músculo detrusor genera ondas de hiperactividad conocidas como contracciones no inhibidas, que son reflejo de una hiperactividad del detrusor (en general asociado a la incontinencia de urgencia).

• **Fase de vaciado:** donde se realiza una flujometría “no fisiológica”, pues la paciente tendrá los electrodos aún colocados durante la micción, pudiendo alterar lo que sería una micción habitual. A diferencia de la flujometría libre, esta fase permitirá conocer la presión con la que se contrae el detrusor durante la fase de vaciado, algo que nos permitirá diferenciar si se trata de un detrusor hipo- o acontractil, o si bien presenta presiones de vaciado muy elevadas, lo que traduciría un problema obstructivo.

Evaluar el impacto sobre la calidad de vida

La IU tiene una gran repercusión en la calidad de vida de las pacientes. Por ello se emplean una diversidad de cuestionarios que tratan de clasificar la gravedad de los síntomas y el grado de preocupación que la IU les produce.

Algunos de los empleados con más frecuencia son los siguientes:

• **International Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ):** es un cuestionario que evalúa la frecuencia, severidad y el impacto en la calidad de vida en los pacientes con IU. Puede emplearse tanto en hombres como mujeres. Cuanta más puntuación, mayor es la severidad de la IU y mayor impacto en la calidad de vida, considerando cualquier puntuación superior a 0 como diagnóstica de IU.

• **ICIQ-SF (Short Form):** Corresponde a una versión breve del cuestionario anterior, validado en su versión española⁵. Resulta de gran utilidad por la sencillez de las preguntas y la brevedad con la que se completa. Constituye una herramienta óptima para aquellas pacientes que vemos por primera vez en consulta o cuando queremos valorar la eficacia de algún tratamiento previo de la incontinencia. El cuestionario se muestra en la tabla 3.

• **King's Health Questionnaire:** consta de 21 ítems correspondientes a 9 aspectos de la calidad de vida de la paciente, incluyendo aspectos físicos, sociales y emocionales. Este cuestionario permite obtener un valor global de la calidad de vida de la paciente con IU y otro específico para cada una de las dimensiones estudiadas⁶.

TABLA 3. Versión breve del "International Consultation on Incontinence Questionnaire" (ICIQ-SF)

International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form	
1. ¿Con qué frecuencia pierde orina?	Puntuación
• Nunca	0
• Una vez a la semana	1
• 2-3 veces por semana	2
• Una vez al día	3
• Varias veces al día	4
• Continuamente	5
2. Indique su opinión acerca de la cantidad de orina que usted cree que se le escapa, es decir, la cantidad de orina que pierde habitualmente (tanto si lleva protección como si no)	
• No se me escapa nada	0
• Muy poca cantidad	2
• Una cantidad moderada	4
• Mucha cantidad	6
3. ¿En qué medida estos escapes de orina han afectado a su vida diaria?	
Nada: 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10: Mucho	
4. ¿Cuándo pierde orina?	
• Nunca	☐
• Antes de llegar al servicio	☐
• Al toser o estornudar	☐
• Mientras duerme	☐
• Al realizar esfuerzos físicos/ejercicio	☐
• Cuando termina de orinar y se ha vestido	☐
• Sin motivo aparente	☐
• De forma continua	☐

Tratamiento

En el tratamiento de la IU se incluyen diversas alternativas no excluyentes y a menudo complementarias. Para decidir el tratamiento más adecuado en cada paciente, no solo se deberá valorar el tipo de incontinencia, sino también las condiciones médicas asociadas, la repercusión de la IU en la paciente y sus preferencias.

De manera general y como resumen, las pacientes con IUE se beneficiarán más de un cambio en su hábito de vida, de la pérdida de peso y de la realización de ejercicios de suelo pélvico, así como de una posterior opción quirúrgica de última línea; mientras que las pacientes aquejadas de IUU se beneficiarán más de un tratamiento farmacológico.

En el caso de que se trate de una incontinencia de características mixtas, deberemos indagar acerca de qué componente es predominante, si de urgencia o de esfuerzo, de modo que centraremos nuestros esfuerzos en el más limitante para la paciente.

Tratamiento conservador

Antes de plantearnos cualquier tipo de tratamiento farmacológico o quirúrgico, debemos iniciar medidas conservadoras.

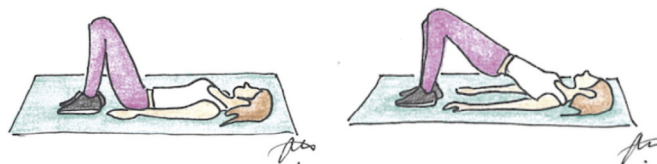


Figura 4. Ejercicios de Kegel para fortalecer el suelo pélvico. Ilustración original de Pablo Oteo Manjavacas.

Estas son:

- Cambios en el estilo de vida: la pérdida de peso, las modificaciones de la dieta, el abandono del hábito tabáquico y el tratamiento de las comorbilidades son maniobras imprescindibles para la mejoría de los síntomas de IU.
- Modificaciones del comportamiento:
 - Disminuir la ingesta de líquidos, sobre todo en las horas previas al descanso nocturno.
 - Evitar el consumo de cafeína, bebidas carbonatadas o té.
 - Emplear medidas para combatir el estreñimiento.
 - Realizar micciones programadas, aumentando progresivamente el intervalo entre micciones para ayudar a asociar el deseo de micción con el vaciado voluntario.
- Ejercicios para fortalecer la musculatura del suelo pélvico: existen multitud de técnicas para ejercitar el suelo pélvico, aunque la más popular es, sin duda, los ejercicios de Kegel. Se trata de unos ejercicios de escasa exigencia física que consisten en realizar contracciones de la musculatura del suelo pélvico a diferentes ritmos e intensidades (fig. 4). Permiten aumentar la fuerza, el volumen y la función de la musculatura mediante la contracción y relajación voluntaria de los músculos elevadores del ano. Estos ejercicios pueden realizarse en el domicilio del paciente con la correcta instrucción previa por parte de enfermería especializada. Aunque son especialmente eficaces en los casos de IUE, han demostrado su eficacia también en IUU o IUM.

Tratamiento farmacológico

El tratamiento farmacológico de la IU está principalmente orientado hacia la incontinencia de urgencia e hiperactividad vesical, aunque también puede ser beneficioso en las formas mixtas. El efecto de estos fármacos no es uniforme; presentan una tasa de respuesta variable y unos efectos adversos que limitan su uso a largo plazo y condicionan una baja adhesión al tratamiento.

Anticolinérgicos

Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la unión de la ACH a los receptores muscarínicos, principalmente M3, suprimiendo las contracciones involuntarias vesicales y aumentando la capacidad vesical.

Hoy en día son los fármacos considerados de primera línea en el tratamiento de la IU y de la incontinencia mixta.

con predominio de urgencia. Los antimuscarínicos producen una mejoría de los síntomas en cerca del 50% de las pacientes y eliminan la IU en el 20-30% de los casos⁷.

Los efectos adversos más frecuentes en estos fármacos son la sequedad de boca (35%) y ojos (1,5-3%), el estreñimiento (1-8%), la cefalea y el deterioro cognitivo en pacientes de edad avanzada⁷, con gran homogeneidad entre las diferentes moléculas. Estos efectos adversos son una de las principales causas de abandono del tratamiento, y dada su alta prevalencia, deben ser notificados a la paciente antes de iniciarlo.

Actualmente existen siete moléculas comercializadas que se diferencian en sus perfiles farmacológicos (tabla 4), su afinidad por diferentes receptores muscarínicos, su farmacocinética y su espectro de efectos adversos.

Todos estos fármacos han demostrado su superioridad respecto a placebo en cuanto a disminuir la frecuencia, urgencia e incontinencia, así como mejorar la puntuación en los cuestionarios de calidad de vida; si bien, comparándolos entre sí ninguno de ellos resultó superior a los demás en el incremento de la calidad de vida y no existe evidencia de su superioridad sobre el tratamiento conservador⁹. Por lo tanto, la elección de alguno de ellos como terapia de primera línea va a depender de las características individualizadas de la paciente y de la experiencia del médico. A su vez, de cara al manejo de la IU en pacientes de edad avanzada, cabe destacar que la fesoterodina, comparada con placebo, ha demostrado su eficacia en pacientes añosos y pluripatológicos sin diferencias significativas en el deterioro de la función cognitiva a las 12 semanas de iniciar el tratamiento¹⁰.

La oxibutinina de administración transdérmica tiene una liberación continua durante 96 horas, lo que supone aplicar dos parches semanales. Esta forma de aplicación produce una menor incidencia de trastornos del sistema nervioso

central comparado con la oxibutinina oral y menos sequedad de boca, con una incidencia de reacciones cutáneas inferior al 5 %⁹.

El hidrocloreuro de propiverina asocia un efecto calcio-modulador a su actividad anticolinérgica, por lo que puede ser una herramienta útil en pacientes sin respuesta a otras moléculas.

Hay escasa evidencia de que los pacientes que no hayan respondido a un primer tratamiento con antimuscarínicos vayan a hacerlo a dosis mayores de la misma molécula o a otra diferente¹¹, aunque estos aumentos de dosis sí suelen acompañarse de una acentuación de los efectos adversos. Pese a ello, ambas maniobras terapéuticas son habituales en la práctica diaria y en los protocolos de tratamiento.

La tasa de abandono de estos fármacos es superior al 60% en la mayoría de las series y suele ocurrir durante los primeros 3 meses de tratamiento. Algunas moléculas, como la tolterodina o la oxibutinina, presentan unas tasas de abandono a los 12 meses particularmente altas, del 68-95%¹². Las principales causas de abandono terapéutico son la baja eficacia del fármaco (41,3%), los efectos adversos (22,4%) y el coste de la medicación (18,7%)^{12,13}.

Se recomienda hacer una revisión de la paciente a las 4 semanas de iniciar el tratamiento con anticolinérgicos, ya que es el tiempo que tardan en hacer efecto y en desarrollar la mayoría de los efectos adversos. Si en este tiempo la paciente presenta una buena tolerancia al fármaco sin un claro beneficio clínico, podemos escalar la dosis o cambiar a una nueva molécula^{8,11}.

Mirabegron

Se trata de un agonista beta-3. Los adrenoceptores beta-3 son los receptores beta predominantes en las células de músculo liso del detrusor vesical y su estimulación, mediada por el sistema simpático, induce la relajación de este músculo.

TABLA 4. Distintos anticolinérgicos disponibles para el tratamiento de la incontinencia urinaria, vía de administración y posología

Molécula	Administración	Dosis inicial recomendada	Dosis máxima	Efectos adversos ⁸
Fesoterodina	Oral	4 mg/24 h	8 mg/24 h	Boca seca, visión borrosa, taquicardia, prolongación QT, somnolencia, confusión, agitación, hipotensión postural, estreñimiento
Oxibutinina	Oral Transdérmica	5 mg/24 h 3,9 mg/24 h		
Cloruro de tropio	Oral	30 mg/24 h	60 mg/24 h	
Solifenacina	Oral	5 mg/24 h	10 mg/24 h	
Tolterodina	Oral	2 mg/24 h	4 mg/24 h	
Hidrocloreuro de propiverina	Oral	30 mg/24 h		
Darifenacina	Oral	7,5 mg/24 h	15 mg/24 h	

Fuente: Validación de la versión española por Espuña et al.⁵.

Por lo tanto, los agonistas beta-3 relajan las fibras de músculo liso de la vejiga durante la fase de llenado mejorando la capacidad vesical¹⁴.

El mirabegron es una molécula desarrollada en 2013 y empleada inicialmente como segunda línea de tratamiento tras un fracaso terapéutico de los fármacos anticolinérgicos. Actualmente se puede emplear como primera línea en pacientes con IUU o mixta con predominio de urgencia, o en terapias combinadas con anticolinérgicos al tener vías de actuación diferentes. Se emplea en dosis de 50 mg cada 24 horas y ha demostrado una reducción de los episodios de urgencia, incontinencia y frecuencia miccional respecto al placebo con una baja tasa de efectos adversos y adecuada seguridad en pacientes de edad avanzada.

Los efectos adversos más frecuentes asociados al mirabegron son la hipertensión (7,3%), la nasofaringitis (3,4%) y las infecciones de orina (3%), aunque su tolerancia global supera ampliamente a la de los anticolinérgicos¹⁵.

Tratamiento farmacológico para incontinencia urinaria de esfuerzo

Aunque generalmente no se emplean en la práctica clínica habitual, podemos indicar:

- Duloxetina: se trata de un inhibidor de la recaptación de la serotonina y noradrenalina que provoca un aumento del tono del esfínter uretral en reposo y durante las contracciones. Está asociado a menores pérdidas de orina y aumentos en la calidad de vida comparado con placebo. Se emplea en dosis de 40 mg cada 12 horas, pero sus bajos índices de eficacia y sus efectos adversos digestivos y del sistema nervioso central relegan el uso de este fármaco para aquellas pacientes que no puedan ser intervenidas quirúrgicamente de su IUE¹⁶.

- Estrógenos: la terapia con estrógenos vaginales puede mejorar la continencia en mujeres posmenopáusicas aumentando la coaptación de mucosa uretral.

Seguimiento de la paciente con tratamiento farmacológico

Una vez iniciado un tratamiento con anticolinérgicos se recomienda un seguimiento en consulta transcurrido el primer mes para comprobar la efectividad del fármaco y la tolerancia de la paciente a este. Una vez lograda la estabilidad se aconseja ampliar el periodo de seguimiento a 6-12 meses. Debemos dedicar especial atención a aquellas pacientes de edad avanzada o con deterioro cognitivo incipiente que hayan iniciado tratamiento con anticolinérgicos. Aquellas pacientes que presentasen RPM moderados o severos (>150 cm³) antes de iniciar el tratamiento deben seguir controles estrictos con

mediciones periódicas de residuo, ya que puede verse incrementado con el uso de estos fármacos¹⁷. Tanto el diario miccional como los cuestionarios de calidad de vida son dos herramientas de gran ayuda para el seguimiento, sobre todo si tenemos un control previo al inicio del tratamiento con el que compararlo. Si la paciente no obtiene mejoría con un anticolinérgico podemos considerar un aumento de dosis, siempre y cuando no haya contraindicación, u ofrecerle otra formulación. Otras alternativas son sustituir el anticolinérgico por mirabegron o iniciar una combinación de ambos como refuerzo o para evitar un aumento de dosis.

En la figura 5 se muestra un algoritmo básico de tratamiento inicial de la IU en la mujer.

¿Cuándo derivar al especialista?

La información aportada por la anamnesis y la exploración física puede ser suficiente para clasificar una IU como complicada. La mayoría de los pacientes que consultan por IU pueden ser manejados en una consulta de atención primaria, pero hay determinados hallazgos que nos hacen pensar en una IU compleja o que constituye un síntoma de otra patología subyacente. Es en estos casos cuando la paciente debe ser derivada de inicio para una valoración por el servicio de urología¹:

- Masas pélvicas o abdominales identificadas durante la exploración.
- IU asociada a prolapso de órganos pélvicos severos o sintomáticos.
- RPM alto o sospecha de incontinencia por rebosamiento.
- IU asociada a dolor suprapúbico.
- IU asociada a hematuria una vez descartada la ITU.
- IU asociada a enfermedad neurológica central o afectación medular.
- Mujeres con IU que recidiva tras haber recibido tratamiento quirúrgico por ese motivo.
- Mujeres con IU y antecedente de radioterapia o cirugía pélvica.

En aquellas mujeres sin incontinencias complicadas en las que se ha realizado una correcta clasificación de la IU y se ha iniciado tratamiento deben ser derivadas para valoración especializada cuando presenten¹:

- Empeoramiento de los síntomas a pesar del tratamiento.
- Aparición de nuevos síntomas.
- Mala respuesta o intolerancia al tratamiento conservador, conductual y farmacológico, con un margen de al menos 3 meses después de haberlo iniciado.

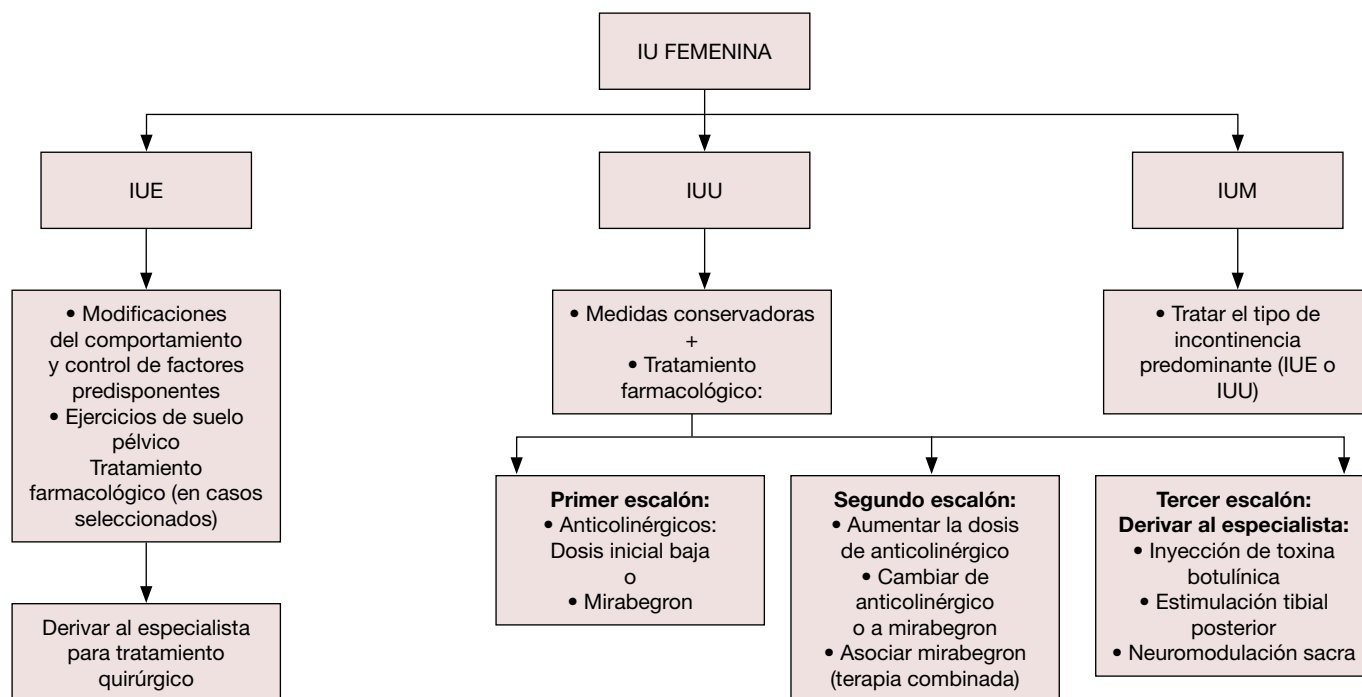


Figura 5. Algoritmo básico para el manejo de los diferentes tipos de incontinencia urinaria en la mujer.

IU: incontinencia urinaria; IUE: incontinencia urinaria de esfuerzo; IUM: incontinencia urinaria mixta; IUU: incontinencia urinaria de urgencia. Ilustración original de Pablo Oteo Manjavacas.

Bibliografía

- Brenes Bermúdez FJ, Cozar Olmo M, Esteban Fuertes M, Fernández-Pro Ledesma A, Molero García JM. Criterios de derivación en incontinencia urinaria para atención primaria. *Semergen*. 2012;11:5.
- Schick E, Dupont C, Bertrand PE, Jolivet-Tremblay M, Tessier J. Predictive value of maximum urethral closure pressure, urethral hypermobility and urethral incompetence in the diagnosis of clinically significant female genuine stress incontinence. *J Urol*. 2004;171:1871.
- Robles JE. La incontinencia urinaria. *An Sist Sanit Navar*. 2006;29:219-31.
- Krht J, Zachoval R, Smith PP, Rosier PF, Valanský L, Martan A, et al. Pad weight testing in the evaluation of urinary incontinence. *Neurourol Urodyn*. 2014;33:507.
- España M, Rebollo P, Puig M. Validación de la versión española del International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form. Un cuestionario para evaluar la incontinencia urinaria. *Med Clin (Barc)*. 2004;122:288-92.
- España P, Castro D, Carbonell C, Dilla T. Comparación entre el cuestionario "ICIQ-UI Short Form" y el "King's Health Questionnaire" como instrumentos de evaluación de la incontinencia urinaria en mujeres. *Actas Urol Esp*. 2007;31:502-10.
- Reynolds WS, McPheeters M, Blume J, Surawicz T, Worley K, Wang L, et al. Comparative Effectiveness of Anticholinergic Therapy for Overactive Bladder in Women: A Systematic Review and Meta-analysis. *Obstet Gynecol*. 2015;125:1423.
- Nadal M, Guerrero A, Pellicer A. Tratamiento farmacológico de la incontinencia urinaria. *FMC*. 2012;19:290-7.
- Salinas-Casado J, Esteban-Fuertes M, Serrano O, Galván J. El valor de la oxibutinina en parche transdérmico en el tratamiento de la vejiga hiperactiva. *Actas Urol Esp*. 2015;39:599-604.
- Dubeau CE, Dubeau CE, Kraus SR, Griebing TL, Newman DK, Wyman JF, et al. Effect of fesoterodina in vulnerable elderly subjects with urgency incontinence: a double blind, placebo controlled trial. *J Urol*. 2014;191:395.
- Kaplan SA, Cardozo L, Herschorn S, Grenabo L, Carlsson M, Arumi D, et al. Efficacy and safety of fesoterodine 8 mg in subjects with overactive bladder after a suboptimal response to tolterodine ER. *Int J Clin Pract*. 2014;68:1065.
- Scarpero H, Sand PK, Kelleher CJ, Berriman S, Bavendam T, Carlsson M. Long-term safety, tolerability, and efficacy of fesoterodine treatment in men and women with overactive bladder symptoms. *Curr Med Res Opin*. 2011;27:921.
- Sears CL, Lewis C, Noel K, Albright TS, Fischer JR. Overactive bladder medication adherence when medication is free to patients. *J Urol*. 2010;183:1077.
- Nitti VW, Auerbach S, Martin N, Calhoun A, Lee M, Herschorn S. Results of a Randomized Phase III Trial of Mirabegron in Patients with Overactive Bladder. *J Urol*. 2013;189:1388-95.
- Chapple CR, Cardozo L, Nitti VW, Siddiqui E, Michel MC. Mirabegron in overactive bladder: a review of efficacy, safety, and tolerability. *Neurourol Urodyn*. 2014;33:17.
- Bent AE, Gousse AE, Hendrix SL, Klutke CG, Monga AK, Yuen CK, et al. Duloxetine compared with placebo for the treatment of women with mixed urinary incontinence. *Neurourol Urodyn*. 2008;27:212.
- Abrams P, Andersson KE, Birder L, Brubaker L, Cardozo L, Chapple C, et al. Fourth International Consultation on Incontinence Recommendations of the International Scientific Committee: Evaluation and treatment of urinary incontinence, pelvic organ prolapse, and fecal incontinence. *Neurourol Urodyn*. 2010;29:213-40.